



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TAHUNAN
KOMITE KEPERAWATAN
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN TAHUNAN
KOMITE KEPERAWATAN
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari berbagai jenis pelayanan seperti pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik yang diberikan kepada pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diberikan, sumber daya manusia tenaga keperawatan sebagai pemberian pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan.

Tenaga keperawatan di Rumah Sakit merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar (jumlahnya antara 50–60%), memiliki jam kerja 24 jam melalui penugasan shift, serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan profesional. Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien dan keluarganya.

Diperlukan tenaga keperawatan yang kompeten, mampu berpikir kritis, selalu berkembang serta memiliki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dan kebidanan dapat diberikan dengan baik, berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya.

Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi tenaga keperawatan dapat terjadi dan terus berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan sistem pengorganisasian yang terencana dan terarah yang diatur oleh suatu wadah keprofesian yang sarat dengan aturan dan tata norma profesi sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan dan kebidanan yang diterima oleh pasien, diberikan oleh tenaga keperawatan dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan dan kebidanan. Mekanisme dan sistem pengorganisasian tersebut adalah Komite Keperawatan.

1.2.Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Tahunan Komite Keperawatan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Direktur Rumah dalam pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi unit Komite Keperawatan.

1.3.2 Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Rumah yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Komite Keperawatan untuk meningkatkan kinerjanya.

II. GAMBARAN UMUM

2.1.Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2.Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang berkelanjutan

2.3.Motto

Sahabat menuju sehat

2.4.7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1.SDM

3.1.1 Pengorganisasian

No	Jabatan	Nama Staf
1	Ketua Komite Keperawatan	Ns. Faris Tiarawan Fadil c, S.Kep
2	Sekretaris Komite Keperawatan	Lola Novira Risdiyanti, A.Md.Kep
3	Sub Kredensial Komite Keperawatan	1. Arif Setya Pamuji, A.Md.Kep 2. Saghita Puspita Sari, A.Md.Kep
4	Sub Mutu Komite Keperawatan	1. Ns. Dhora Putri Meryda S.Kep 2. Murwani Suryaning Suoartinah, AMd. Kep
5	Sub Etik dan Disiplin Komite Keperawatan	1. Ns. Sherly Rosita, S.Kep 2. Amilatul Kholifah, A.Md.Kep

3.1.2 Ketenagaan Perawat dan Bidan

a. Berdasarkan Level Klinis

No	Unit	Level Klinis				
		Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3	PK 4
1	ICU	4	4	8	1	0
2	IGD	6	5	14	0	0
3	IKO	0	0	8	3	0
4	IRJA	0	4	22	0	0
5	Maternitas	0	0	11	0	0
6	Neonatologi	0	2	7	0	0
7	IRNA 2C	1	5	2	0	0
8	IRNA 3C Dewasa & 4A	3	6	9	0	0
9	IRNA 3C Anak	4	3	8	0	0
10	IRNA 5C	2	3	5	0	0
11	IRNA 6, 7, 8	7	8	6	0	0

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Unit	DIII Kep	DIV Kep	Ners	S2 Kep
1	ICU	7	1	9	0
2	IGD	12	3	10	0
3	IKO	5	6	0	0
4	IRJA	15	1	10	0
5	Maternitas	10	1	0	0
6	Neonatologi	5	4	0	0
7	IRNA 2C	2	1	5	0
8	IRNA 3C Dewasa & 4A	8	1	9	0
9	IRNA 3C Anak	10	5	0	0
10	IRNA 5C	6	1	3	0
11	IRNA 6, 7, 8	13	1	7	0

3.2.Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Hasil
1	Pembuatan Perangkat Kerja	a. Membuat program kerja Komite Keperawatan untuk tahun 2026	Perangkat kerja sudah dilakukan sesuai jadwal

		b. Membuat Logbook sesuai dengan area keperawatan c. Membuat White Paper Keperawatan d. Merevisi instrument kredensial berdasarkan level jenjang karir dan area keperawatan	
2	Kredensial	a. Mapping staf keperawatan berdasarkan level jenjang karir b. Melakukan assesmen keperawatan oleh Assesor kompetensi perawat c. Melakukan kredensial berdasarkan hasil assesmen kompetensi perawat	Kredensial staf baru tidak dilakukan tahun ini karena tidak ada staf perawat dan bidan baru
3	Audit Mutu Keperawatan	a. Penyusunan Indikator Mutu Keperawatan b. Pelaksanaan audit keperawatan baik secara klinis maupun dokumentasi	Audit kasus mulai dijalankan pada pertengahan triwulan 3 (Agustus 2025)
4	Audit Etik Keperawatan	a. Identifikasi masalah yang terjadi b. Analisa masalah c. Tindak lanjut masalah	Masalah kasus etik keperawatan / bidan sudah dilakukan penanganan sesuai prosedur etik.

3.3.Evaluasi Kinerja Staf

Evaluasi kepatuhan terhadap etika profesi dan disiplin kerja dilakukan melalui pengamatan/supervisi dan laporan unit.

3.4.Pendidikan dan Pelatihan

3.4.1. Diklat Internal

No	Nama Diklat	Tanggal Penyelenggaraan	Sasaran
-	-	-	-

3.4.2. Diklat Eksternal

No	Nama Diklat	Tanggal Penyelenggaraan	Nama Staf
1	Sosialisasi dari Konsil Kesehatan Indonesia terkait “Mutu & Disiplin Profesi Keperawatan”	Agustus 2025	12 orang perawat dan perwakilan dari unit

3.5.Fasilitas Kesehatan dan K3

No	Kesehatan dan Keselamatan Staf	Upaya Pencegahan	Jumlah Kejadian
1	Tertusuk jarum	a. Penggunaan tehknik one hand	2

		b. Penggunaan sarung tangan saat pengambilan sampling/ pemasangan infus.	
2	Terpajan penyakit	a. Pengguna APD (masker) pada pasien dengan kasus airborne b. Penggunaan APD (sarung tangan) pada pasien dengan kasus hepatitis dan HIV c. Penggunaan APD lengkap pada kasus penyakit kompleks d. Cuci tangan 6 langkah, 5 momen	0
3	Kecelakaan lalu lintas		0
4	Kekerasan terhadap staf	a. Pelatihan building karakter ESQ untuk setiap staf dengan tujuan membentuk pribadi staf yang tanggung berdasarkan 7 nilaibudi utama b. Menempatkan CCTV di setiap area yang ditentukan c. Kepatuhan terhadap semua SPO	0

IV. KINERJA PRODUKTIFITAS

4.1 . Jumlah penanganan kasus Etik Keperawatan yang ditangani.
Tabel 4.1 Data penanganan kasus Etik Keperawatan triwulan III tahun 2025.

Tanggal	Jenis Pelanggaran	Unit	Kategori Pelanggaran Kasus	Jumlah Kasus	Bentuk Pembinaan/Teguran	Hasil Pembinaan	Tindak Lanjut	Petugas Pembina	Status
29/07/2025	Kejadian komplain pada Google review (bintang 1) karena sikap petugas (perawat) yang dianggap tidak baik.	IRJA	Pelanggaran sedang-berat dengan objek tanggung jawab perawat terhadap pasien.	1	- Teguran Lisan - SP 1 (sesuai tatib RS) - Pembinaan oleh Karu unit	Perawat memahami kesalahan dan berkomitmen tidak mengulangi serta akan membantu menaikkan rating google review RS.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRJA	Selesai
18/10/2025	Kejadian komplain Karu IRNA 5C kepada perawat IRJA yang dianggap melakukan fitnah dengan menganggap menyebarkan berita tidak benar.	IRJA	Riangan (Kesalahpahaman antar staf)	1	- Klarifikasi - Mediasi	Masing-masing perawat dan pihak terkait paham kesalahan masing-masing dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman diantara mereka, sudah saling memaafkan dan berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi antar perawat.	Monitoring perilaku dan komunikasi antar perawat.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

Analisa:

Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 2 kasus pelanggaran etik keperawatan yang ditangani oleh Sub Komite Etik Keperawatan. Kasus pertama berasal dari unit IRJA (Rawat Jalan) berupa komplain publik melalui Google Review yang menyoroti sikap petugas terhadap pasien. Kasus kedua terjadi di unit IGD, terkait ketidaksesuaian tindakan dan refund biaya pasien di luar ketentuan SPO rumah sakit. Dari hasil penelusuran dan klarifikasi, diperoleh beberapa poin analisa:

- Faktor individu: kurangnya kontrol diri dan etika komunikasi beberapa petugas saat menghadapi pasien, terutama pada kondisi padat pelayanan.
- Faktor sistem: masih kurangnya sosialisasi dan supervisi rutin tentang penerapan etika profesi dan komunikasi terapeutik.

- Faktor lingkungan: tekanan beban kerja dan situasi darurat di IGD yang berpotensi menurunkan kualitas interaksi dengan pasien.
 - Faktor organisasi: mekanisme pelaporan dan umpan balik terhadap keluhan pasien belum tersampaikan cepat ke Sub Komite Etik.
- Secara umum, setelah dilakukan pembinaan dan teguran lisan oleh Kepala Ruangan serta Sub Komite Etik, kedua petugas telah memahami kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi. Tidak ditemukan unsur pelanggaran berat yang memerlukan tindak lanjut disiplin lanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan etika profesi perawat	Seluruh perawat RS Prima Husada	Melaksanakan refreshment etika keperawatan dan komunikasi terapeutik di setiap unit	Sub Komite Etik & Komite Keperawatan	Oktober 2025
Menurunkan potensi keluhan pasien akibat sikap petugas	Unit IGD & IRJA	Supervisi rutin perilaku petugas dan simulasi komunikasi efektif saat menghadapi pasien	Kepala Ruang & Bidang Keperawatan	Oktober–Desember 2025
Memperkuat sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus etik	Semua unit pelayanan	Membuat formulir pelaporan etik sederhana dan grup koordinasi internal antar kepala ruangan	Sub Komite Etik & SDM	November 2025
Meningkatkan citra dan kepuasan pasien	Unit pelayanan rawat jalan dan IGD	Melakukan survei kepuasan pasca pembinaan dan evaluasi respon pasien	Komite Keperawatan & PKRS	Desember 2025

Tabel 4.2 Data penanganan kasus Etik Keperawatan triwulan IV tahun 2025.

Tanggal	Jenis Pelanggaran	Unit	Kategori Pelanggaran Kasus	Jumlah Kasus	Bentuk Pembinaan/Teguran	Hasil Pembinaan	Tindak Lanjut	Petugas Pembina	Status
13/10/2025	Kurang menghargai privacy, hasil kerja, martabat profesi lain (dokter), dengan	IRNA 5C	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab	1	- Teguran Lisan	Perawat memahami kesalahan komunikasi yang dibuat dan berkomitmen tidak mengulangi lagi.	Monitoring perilaku petugas	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

	membandingkan hasil kerja dpjp dengan dpjp lain.		perawat terhadap profesi lain.				dalam pelayanan.	Kepala Ruang IRNA 5C	
18/10/2025	Kejadian komplain Karu IRNA 5C kepada perawat IRJA yang dianggap melakukan fitnah dengan menganggap menyebarkan berita tidak benar.	IRJA	Riangan (Kesalahpahaman antar staf)	1	- Klarifikasi - Mediasi	Masing-masing perawat dan pihak terkait paham kesalahan masing-masing dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman diantara mereka, sudah saling memaafkan dan berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi antar perawat.	Monitoring perilaku dan komunikasi antar perawat.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

Analisa :

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kasus etik keperawatan yang ditangani oleh Sub Komite Etik Keperawatan. Seluruh kasus termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, yang didominasi oleh masalah komunikasi dan pemahaman antar tenaga keperawatan serta kurangnya sikap saling menghargai profesionalisme antar profesi.

Bentuk penanganan yang diberikan berupa teguran lisan, klarifikasi, dan mediasi, yang menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan sanksi. Hasil pembinaan menunjukkan adanya perubahan sikap positif, meningkatnya pemahaman terhadap kesalahan komunikasi, serta komitmen petugas untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Meskipun seluruh kasus berstatus selesai, kejadian ini mengindikasikan perlunya penguatan komunikasi efektif, etika profesi, dan budaya saling menghargai di lingkungan kerja, khususnya di unit pelayanan dengan intensitas kerja tinggi seperti IRNA dan IRJA.

Rencana Tindak Lanjut

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan pemahaman etika profesi keperawatan	Seluruh perawat IRNA & IRJA	Sosialisasi ulang kode etik keperawatan dan etika komunikasi profesional	Sub Komite Etik Keperawatan, SDM Keperawatan	Triwulan I 2026
Mencegah terulangnya konflik antar tenaga keperawatan	Perawat pelaksana di unit pelayanan	Edukasi komunikasi efektif dan manajemen konflik dalam pelayanan	Sub Komite Etik Keperawatan	Triwulan I 2026
Memperkuat budaya saling menghargai antar profesi	Perawat dan tenaga kesehatan terkait	Pembinaan berkelanjutan melalui briefing unit dan role model kepala ruangan	Kepala Ruangan, Komite Keperawatan	Berkelanjutan
Meningkatkan deteksi dini permasalahan etik	Kepala Ruangan dan Koordinator Shift	Monitoring perilaku profesional dan pelaporan dini potensi masalah etik	Kepala Ruangan, Sub Komite Etik	Berkelanjutan

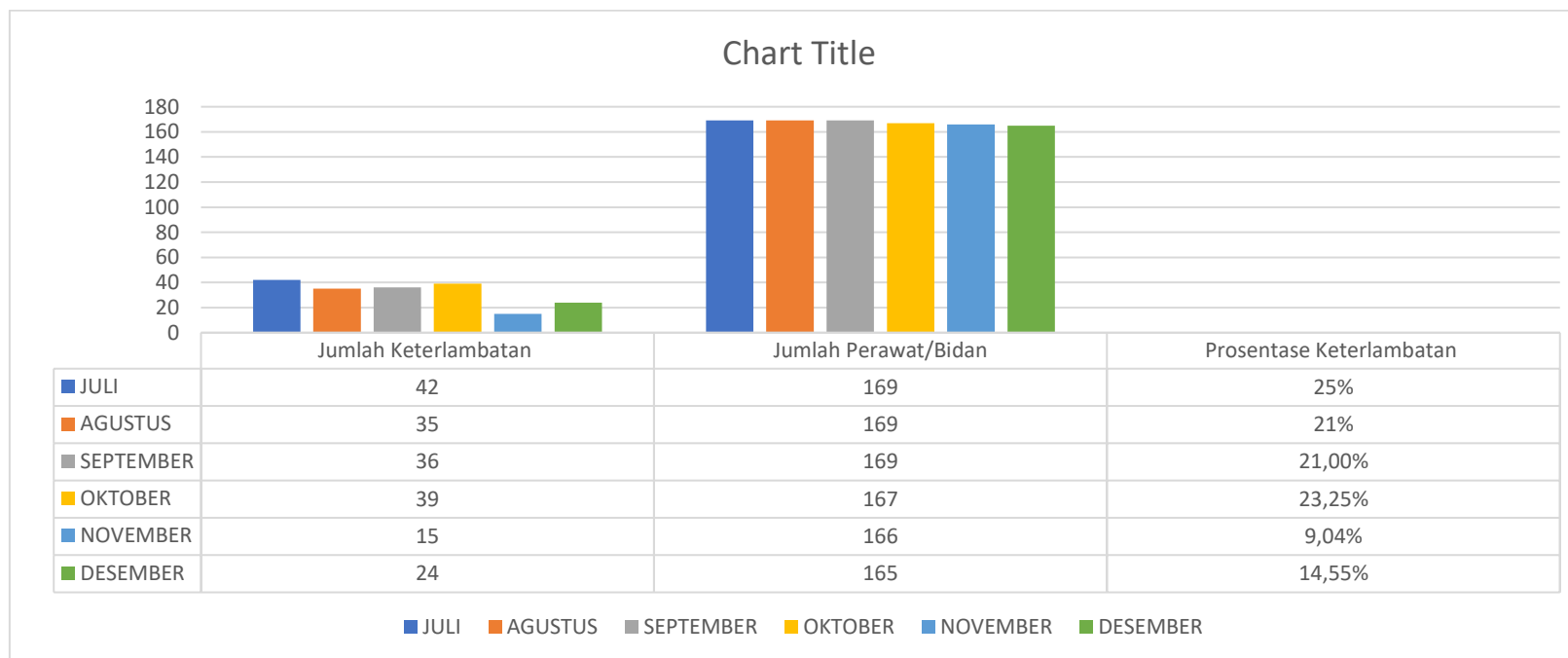
V. Evaluasi Kinerja Staf

5.1 Evaluasi Kinerja Staf Sub Etik

Evaluasi kepatuhan terhadap etika profesi dan disiplin kerja dilakukan melalui pengamatan/supervisi dan laporan unit.

Table 5.1 Data kedisiplinan kerja staf perawat/bidan triwulan III tahun 2025

Periode Bulan	Jumlah Keterlambatan (orang)	Jumlah Perawat/Bidan	Prosentase Keterlambatan
Juli 2025	42	169	25%
Agustus 2025	35	169	21%
September 2025	36	169	21%
Oktober 2025	39	167	23,35%
November 2025	15	166	9,04%
Desember 2025	24	165	14,55%



Analisa :

Berdasarkan data keterlambatan kerja staf perawat/bidan selama Triwulan III Tahun 2025, terjadi penurunan jumlah keterlambatan dari bulan Juli sebanyak 42 orang (25%) menjadi 35 orang (21%) pada bulan Agustus, dan relatif stabil pada bulan September dengan 36 orang (21%).

Meskipun terdapat perbaikan pada awal triwulan, angka keterlambatan masih tergolong cukup tinggi karena idealnya tingkat keterlambatan berada di bawah 10%. Namun jika dilihat dari jumlah keterlambatan per masing-masing orang, rata-rata 94% hanya terlambat 1-3 kali dalam 1 bulan, 6% sisanya terlambat 4-7 kali, tidak ada yang melebihi terlambat >7 kali.

Faktor penyebab yang diidentifikasi antara lain:

- Faktor individu: kurangnya kedisiplinan dan manajemen waktu dari beberapa staf.
- Faktor lingkungan kerja: jarak tempat tinggal dan jadwal shift malam yang berdekatan dengan shift pagi berikutnya.
- Faktor sistem: pengawasan kehadiran belum dilakukan secara konsisten di seluruh unit.
- Faktor motivasi: belum adanya sistem penghargaan atau sanksi yang diterapkan secara tegas.

Berdasarkan data keterlambatan kerja staf perawat/bidan selama Triwulan IV Tahun 2025, terjadi penurunan jumlah keterlambatan dari bulan Oktober sebanyak 39 orang (23,35%) menjadi 15 orang (9,04%) pada bulan November, dan sedikit meningkat pada Desember sebanyak 24 orang (14,55%).

Secara keseluruhan, kedisiplinan kerja perawat/bidan pada triwulan IV tahun 2025 belum stabil, dengan tingkat keterlambatan tertinggi pada Oktober dan terendah pada November. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi disiplin kerja.

Namun jika dilihat dari jumlah keterlambatan per masing-masing orang, rata-rata 94,87%% hanya terlambat 1-3 kali dalam 1 bulan, 5,13%% sisanya terlambat 4-7 kali, tidak ada yang melebihi terlambat >7 kali.

Faktor penyebab yang diidentifikasi antara lain:

- Faktor individu: Kurangnya kesadaran dan komitmen individu terhadap kedisiplinan waktu. Masalah pribadi atau keluarga yang mempengaruhi kesiapan hadir tepat waktu.
- Faktor lingkungan kerja: Kondisi lalu lintas, cuaca, atau jarak tempat tinggal ke tempat kerja. Pada bulan Desember, kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas akhir tahun dan peningkatan kebutuhan pribadi.
- Faktor sistem: Jadwal kerja shift malam atau pergantian shift yang padat dapat menyebabkan kelelahan fisik, sehingga berdampak pada ketepatan waktu masuk kerja.
- Faktor motivasi: belum adanya sistem penghargaan atau sanksi yang diterapkan secara tegas.

RENCANA TINDAK LANJUT

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan kedisiplinan staf keperawatan dalam ketepatan waktu hadir kerja	Seluruh perawat dan bidan	Melakukan sosialisasi kembali tentang pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab profesi	Sub Komite Etik & Kepala Ruangan	Oktober 2025
Menurunkan tingkat keterlambatan staf keperawatan hingga <15%	Seluruh unit pelayanan perawatan pasien	Menerapkan sistem teguran tertulis dan pembinaan bagi staf dengan keterlambatan berulang	Kepala Ruangan & SDM	Oktober–Desember 2025
Meningkatkan motivasi kerja dan tanggung jawab etika profesi	Seluruh staf keperawatan	Memberikan penghargaan bagi staf/unit dengan kehadiran 100% tepat waktu setiap bulan	Komite Keperawatan & SDM	Mulai November 2025
Memperkuat sistem pengawasan kehadiran staf	Seluruh unit pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan absensi digital dan evaluasi bulanan oleh Sub Komite Etik	Sub Komite Etik & SDM	Rutin setiap bulan

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan disiplin waktu kerja perawat/bidan	Seluruh perawat dan bidan	Monitoring kehadiran melalui absensi harian dan rekap bulanan keterlambatan	Kepala Ruangan, SDM Keperawatan	Setiap hari / Bulanan
Menurunkan angka keterlambatan	Perawat/bidan yang sering terlambat	Sosialisasi ulang kebijakan jam kerja dan SOP kedisiplinan	Kepala Ruangan	Minggu ke-1 bulan berjalan
Meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja	Seluruh perawat dan bidan	Penegasan aturan disiplin dan batas toleransi keterlambatan	Manajer Keperawatan	Setiap bulan
Memberikan motivasi kerja	Perawat/bidan dengan kehadiran terbaik	Pemberian reward/apresiasi kehadiran terbaik	Manajemen Keperawatan	Setiap triwulan
Mengurangi keterlambatan akibat kelelahan kerja	Perawat/bidan shift	Evaluasi dan penyesuaian jadwal shift serta beban kerja	Kepala Ruangan, Penjadwal	Setiap bulan
Mengatasi keterlambatan berulang	Perawat/bidan yang terlambat ≥ 3 kali	Pembinaan individu dan konseling	Kepala Ruangan	Sesuai kebutuhan
Mencapai target penurunan keterlambatan $\leq 10\%$	Seluruh perawat dan bidan	Evaluasi hasil RTL dan tindak lanjut perbaikan	Tim Mutu, Manajer Keperawatan	Setiap triwulan

5.2 Evaluasi Kinerja Staf Sub Mutu

- Evaluasi terhadap Mutu Keperawatan dilakukan melalui pengamatan/supervisi dan laporan unit.
- Tabel 1.4 Data Supervisi berkala pengendalian Mutu Keperawatan triwulan IV tahun 2025

Aspek yang dinilai	Masalah yang ditemukan	Bulan			Rekomendasi
		Okt	Nov	Des	
Pembagian Tugas dan wewenang di Ruang	Pembagian tugas di unit sudah berjalan dengan baik	95%	100%	100%	-
Observasi pelaksanaan Tindakan keperawatan	Pelaksanaan tindakan keperawatan beberapa sudah berjalan baik, tetapi masih ada yang tidak sesuai	90%	93,2%	96%	Peningkatan kualitas asuhan, Keselamatan pasien
Penggunaan alat yang efektif dan ekonomis	Penggunaan alat dan BHP sudah sesuai kebutuhan pasien	100%	100%	100%	-
Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan	Pendokumentasian asuhan keperawatan di ERM sudah lengkap di beberapa unit, namun ada yang tidak lengkap	87%	90%	95%	Peningkatan supervisi rutin, pengelolaan beban kerja perawat, penekanan pemahaman perawat tentang standar (SLKI, SDKI, SIKI)

Analisa:
Berdasarkan data supervisi yang dilaksanakan selama Triwulan IV Tahun 2025 melalui observasi, terjadi peningkatan setiap bulannya walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Untuk Observasi pelaksanaan Tindakan keperawatan

mengalami kenaikan sebanyak 3-4% setiap bulannya. Pada aspek Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan juga mengalami peningkatan 5-6% setiap bulannya.

PDSA Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Tahun 2025

Problem	Berdasarkan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosentase kepatuhan pelaksanaan Tindakan Keperawatan pada tahun 2025 masih belum mencapai standart. Kepatuhan pelaksanaan Tindakan Keperawatan belum mencapai standart karena masih ditemukan beberapa tindakan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada. Perawat melakukan tindakan karena merasa sudah biasa sehingga tidak memperhatikan SOP yang berlaku
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pelaksanaan Tindakan keperawatan sesuai dengan SOP
Plan	Rencana : Meningkatkan capaian kepatuhan pelaksanaan Tindakan keperawatan sesuai dengan SOP Harapan : Capaian kepatuhan pelaksanaan Tindakan keperawatan sesuai dengan SOP dapat mencapai standart.
Do	a) Memberikan bimbingan dan sosialisasi ulang mengenai SPO b) Meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan c) Memperbaikai system SDM yang sudah berjalan
Studi	Berdasarkan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosentase kepatuhan pelaksanaan Tindakan keperawatan sesuai dengan SOP pada tahun 2025 masih belum mencapai standart. Kepatuhan pelaksanaan Tindakan Keperawatan belum mencapai standart karena masih ditemukan beberapa tindakan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada. Perawat melakukan tindakan karena merasa sudah biasa sehingga tidak memperhatikan SOP yang berlaku.
Action	Melakukan koordinasi dengan kepala ruang agar menindaklanjuti anggota yang tidak patuh dalam pelaksanaan Tindakan keperawatan

PDSA Capaian Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan Tahun 2025

Problem	Berdasarkan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosentase Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan pada tahun 2025 masih belum mencapai standart. Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan belum mencapai standart karena masih ditemukan beberapa ERM tidak terisi dan beberapa terisi dengan tidak lengkap. Perawat hanya mengisi lembar yang di pahami saja.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan
Plan	Rencana :

	Meningkatkan capaian Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan Harapan : Capaian Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan dapat mencapai standart.
Do	a) Meningkatkan frekuensi pengawasan dan penilaian berkala oleh kepala ruangan untuk memastikan dokumentasi sesuai dengan standart b) Mengadakan pelatihan pendokumentasian secara berkala, termasuk pemahaman standar (SDKI, SIKI, SLKI) c) Meninjau ulang beban kerja dan jumlah tenaga, melakukan perekrutan dan menyesuaikan penempatan SDM dengan beban kerja agar perawat tidak kewalahan. d) Menerapkan system Reward dan Punishment
Studi	Berdasarkan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosentase Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan pada tahun 2025 masih belum mencapai standart. Kepatuhan pendokumentasian asuhan keperawatan belum mencapai standart karena masih ditemukan beberapa ERM tidak terisi dan beberapa terisi dengan tidak lengkap. Perawat hanya mengisi lembar yang di pahami saja.
Action	Melakukan koordinasi dengan kepala ruang agar menindaklanjuti anggota yang tidak patuh dalam pendokumentasian asuhan keperawatan

4.2 . Jumlah Audit Keperawatan yang dilakukan pada triwulan IV

Tabel 4.2 Data Audit Keperawatan triwulan IV tahun 2025.

No	Tanggal	Kasus	IKP	Tindak Lanjut	PIC	Audit
1	13/10/2025	TTV dan skrining tidak bejalan	Sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD	√
2	15/10/2025	Keterlambatan pemeriksaan penunjang,tidak tercatat tindakan brething,tidak dilakukan reassessment berulang,pasien seharusnya p1 tidak ada catatan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD Kepala Ruang 5c Kepala Ruang ICU	√
3	16/10/2025	Pasien kondisi belum stabil, pindah ruangan penurunan kondisi, kurang observasi perawatan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD Kepala Ruang 5c Kepala Ruang ICU	√

4	21/10/2025	TTV tidak sesuai dari IGD ke ruangan	KPC	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang 4A	√
5	06/11/2025	EWS tidak dilakukan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD Kepala Ruang 4A	√
6	23/11/2026	EWS tidak dilakukan	-	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang 5c	
7	29/11/2026	EWS tidak dilakukan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD	√
8	1/12/2025	TTV dan skrining tidak bejalan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang IGD	

				2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)		
9	2/12/2025	TTV tidak sesuai dari IGD ke ruangan	sentinel	1. Sub Komite Mutu memaparkan hasil audit kepada seluruh staf keperawatan, kepala ruangan, dan bidang keperawatan 2. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau hasil yang rendah, harus dicari penyebabnya menggunakan metode seperti <i>Fishbone Diagram</i> atau <i>5 Whys</i> 3. Penyusunan Rencana Perbaikan (Action Plan) 4. Pelaksanaan Perbaikan (Implementasi)	Sub Komite Mutu Kep. Kepala Ruang 7A	

Analisa:

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) Audit kasus, yang dilakukan audit keperawatan ada 6 kasus.

Bentuk tindak lanjut yang diberikan yaitu melakukan audit Bersama yang berkoordinasi dengan Tim Ketua PMKP, Ketua komite keperawatan , DPJP dan staff yang terlibat. Hasil koordinasi yang dilakukan di dalam audit bertujuan untuk melakukan perbaikan baik di pelayanan, system maupun komunikasi antar sejawat. Sehingga Mutu pelayanan yang di inginkan tercapai. Produktivitas yang terlalu tinggi tanpa kontrol dapat menyebabkan **Burnout**, yang secara langsung meningkatkan risiko **Medical Error** (penurunan mutu). Sebaliknya, produktivitas yang terlalu rendah menunjukkan adanya pemborosan sumber daya rumah sakit.

BAB V

REKOMENDASI KOMITE KEPERAWATAN

5.1 Latar Belakang Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Keperawatan, serta Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan selama periode pelaporan, Komite Keperawatan memandang perlu adanya penguatan program pengembangan kompetensi perawat yang terencana, terukur, dan terintegrasi. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi, mutu pelayanan, serta penerapan etik keperawatan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem pembinaan yang berkelanjutan, khususnya dalam bentuk dokumentasi dan monitoring praktik klinis perawat.

5.2 Rekomendasi Umum

Komite Keperawatan merekomendasikan agar pengembangan kompetensi perawat dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi antara pelatihan, kewenangan klinis, mutu pelayanan, dan etik keperawatan, dengan logbook terintegrasi sebagai instrumen utama monitoring, evaluasi, dan pembinaan profesional perawat.

5.3 Rekomendasi Berdasarkan Sub Komite

5.3.1 Rekomendasi Sub Komite Kredensial

Menyusun dan menetapkan logbook terintegrasi berbasis kewenangan klinis (PK 1–PK 3) yang digunakan secara seragam di seluruh unit pelayanan. Mengintegrasikan hasil pelatihan, praktik klinis, dan evaluasi kompetensi ke dalam proses kredensial dan rekredensial perawat. Menjadikan logbook sebagai dokumen pendukung utama dalam: evaluasi kewenangan klinis, rekomendasi pengembangan kompetensi, penetapan kebutuhan pelatihan lanjutan.

5.3.2 Rekomendasi Sub Komite Mutu Keperawatan

Mengarahkan program pelatihan keperawatan berbasis kebutuhan mutu dan keselamatan pasien, khususnya pada area berisiko tinggi. Menetapkan pelatihan prioritas sebagai berikut:

ACLS (lanjutan dan penyegaran),

Early Warning System (EWS),

Triage IGD, dokumentasi asuhan keperawatan berbasis mutu. Mengintegrasikan indikator mutu keperawatan dan kepatuhan dokumentasi ke dalam logbook individu sebagai bagian dari evaluasi praktik klinis.

5.3.3 Rekomendasi Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan

Melaksanakan pelatihan etik dan legal keperawatan berbasis kasus klinis (case-based learning), terutama pada kondisi emergensi dan pengambilan keputusan cepat. Memasukkan aspek penerapan kode etik keperawatan ke dalam logbook sebagai bagian dari pembinaan profesional, bukan semata-mata aspek disiplin. Mengembangkan mekanisme supervisi dan pembinaan etik yang terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem logbook.

5.4 Rekomendasi Program Strategis Komite Keperawatan

Sebagai tindak lanjut, Komite Keperawatan merekomendasikan program strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pelatihan Terencana dan Berkelanjutan, meliputi:
2. Pelatihan klinis berbasis kewenangan klinis,
3. Pelatihan mutu dan keselamatan pasien,
4. Pelatihan etik dan profesionalisme keperawatan.
5. Penyusunan dan Implementasi Logbook Terintegrasi, yang mencakup: identitas dan level kompetensi perawat, kewenangan klinis, tindakan keperawatan, pelatihan yang diikuti, evaluasi mutu dan keselamatan pasien, penerapan etik dan hasil supervisi.

Pemanfaatan Logbook sebagai Alat Pembinaan, bukan hanya administrasi, tetapi sebagai dasar: penilaian kinerja, rekomendasi pengembangan kompetensi, perencanaan pelatihan tahunan.

5.5 Penutup

Dengan ditetapkannya rekomendasi ini, diharapkan pelaksanaan pengembangan kompetensi, peningkatan mutu pelayanan, serta penerapan etik keperawatan dapat berjalan lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan secara berkala melalui observasi langsung dan laporan dari kepala ruangan. Evaluasi hasil dilakukan setiap bulan dalam rapat rutin Komite Keperawatan dengan pembahasan tindak lanjut terhadap kasus etik dan rencana pembinaan selanjutnya.

6.1 Monitoring dan Evaluasi dari sub etik komite keperawatan:

1. Meningkatkan sosialisasi etika pelayanan keperawatan setiap triwulan.
2. Membangun system pelaporan online/elektronik untuk pelanggaran etik keperawatan.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan SDM dalam pembinaan disiplin staf.
4. Tidak adanya pengulangan kasus etik serupa.
5. Menurunnya jumlah komplain terkait komunikasi dan sikap profesional.
6. Adanya perubahan sikap dan perilaku positif pada petugas yang telah dibina.
7. Hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan komite keperawatan dan menjadi dasar perbaikan program pembinaan selanjutnya.

6.2 Monitoring dan evaluasi sub mutu komite keperawatan

1. Supervise Klinis: Kepala Ruangan atau *Clinical Instructor* melakukan keliling (*round*) untuk melihat apakah perawat melakukan tindakan sesuai SPO (misal: teknik menyuntik atau pemasangan infus).
2. Dashboards Indikator Mutu: Pengumpulan data harian terkait indikator kunci (Angka Jatuh, Dekubitus, Infeksi). Data ini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik di nurse station.
3. Spot Check Dokumentasi: Pengecekan mendadak pada rekam medis pasien untuk memastikan asuhan keperawatan ditulis segera setelah dilakukan (bukan di akhir shift).
4. Logbook Produktivitas: Memantau distribusi beban kerja staf setiap hari agar tidak terjadi ketimpangan yang berisiko pada keselamatan pasien

Evaluasi bertujuan untuk menganalisis tren data dan mengambil keputusan strategis.

1. Rapat Koordinasi Mutu: Pertemuan bulanan antara Sub Komite Mutu dengan para Kepala Ruangan untuk membahas pencapaian indikator.
2. Analisis Tren: Membandingkan data bulan ini dengan bulan sebelumnya. Contoh: "Mengapa angka Phlebitis naik di bulan ini? Apakah karena kualitas handscoen yang menurun atau teknik fiksasi yang salah?"
3. Evaluasi Kinerja Individu: Menilai bagaimana kepatuhan setiap perawat terhadap standar mutu memengaruhi penilaian kinerja tahunan mereka.

Review Plan-Do-Check-Act (PDCA): Menilai apakah rencana perbaikan yang dibuat pada bulan lalu benar-benar efektif menurunkan angka insiden

Berdasarkan hasil audit keperawatan pada Triwulan IV Tahun 2025 yang berkaitan dengan banyaknya mis komunikasi yang terjadi, kurangnya kesadaran staf dalam melakukan pemantauan khususnya pada pasien tertentu, maka di perlukan kembali evaluasi yang melibatkan kepala ruang dalam pemantauan staff melakukan tindakan keperawatan.

Melalui kegiatan monitoring tindakan dan audit kasus, diharapkan tidak terjadi pengulangan kasus serupa, meningkatnya kesadaran etika dan profesionalisme perawat, serta terciptanya lingkungan kerja yang kondusif guna mendukung mutu dan keselamatan pelayanan keperawatan di rumah sakit.

VII PENUTUP

Laporan kinerja Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan triwulan IV tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembinaan etika serta disiplin profesi keperawatan di RS Prima Husada. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan mutu pelayanan keperawatan, memperkuat budaya etik dan disiplin di lingkungan rumah sakit, serta memperbaiki sistem pembinaan profesi secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, baik dalam aspek pelaksanaan kegiatan maupun dokumentasi. Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Ketua Komite Keperawatan serta manajemen rumah sakit sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan kegiatan Sub Komite Etik Keperawatan di masa mendatang. Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dilaporkan Kepada,

Ketua Komite Keperawatan



Fariz Tiarawan Fadil C, S. Kep. Ns

Malang, 10 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Lampiran 1

Data Staf Keperawatan Berdasarkan Level Jenjang Karir

No	NAMA	LEVEL PK	UNIT KERJA
1	Afni Nur Ainy S.Kep., Ns	PK 2	IGD
2	Lita Oktavian, Amd.Kep	PK 2	IGD
3	Beny Wahyudy, S.Kep., Ns	PK 2	IGD
4	Rizal Ari Wicaksono, Amd.Kep	PK 2	IGD
5	Kholil Rohman, Amd.Kep	PK 2	IGD
6	Noor Rochmat, S.Tr.Kep	PK 1	IGD
7	Wijaya Risky Ramadhan, Amd.Kep	PK 2	IGD
8	Rega Wahyu S.A, Amd.Kep	PK 2	IGD
9	Dwinta Widya Navita, Amd.Kep	PK 2	IGD
10	Zahrocha Fathmanda R, Amd.Kep	PK 1	IGD
11	Nasmawati Hi, Abd. Azis, S.Kep., Ns	PK 1	IGD
12	Fakhrur Rifqi A, S.Kep. Ns	PRA PK	IGD
13	Oky Taat Setiawan, S.Kep., Ns	PK 1	IGD
14	Nungky Putri Pebrianti, Amd.Kep	PK 2	IGD
15	Lusianah Nurul Islamiyah, Amd.Kep	PRA PK	IGD
16	Rani Kharisma Rosul, S.Kep., Ns	PK 1	IGD
17	Tiara Anggita Putri, S.Ter.Kep., Ns	PRA PK	IGD
18	Rizki Esa Wisnu Wardana, S.Kep. Ns	PRA PK	IGD
19	Shynta Dinar Audia, S.Kep., Ns	PRA PK	IGD
20	Rosi Slamet Saputri, S.Kep. Ns	PRA PK	IGD
21	Anggarani Dwi Pratiwi, Amd.Keb	PK 2	IGD
22	Wahyuni, S.Tr.Keb	PK 2	IGD
23	Nining Trisari, Amd.Keb	PK 2	IGD
24	Indri Khatul Inaya, S.ST.Keb	PK 2	IGD
25	Auliya Paramita, Amd.Keb	PK 2	IGD
26	Ns. Siti Durotul Ibadiyah, S.Kep	PK 3	IKO
27	Rendhi Adyatma, Amd.Kep	PK 2	IKO
28	Kiki Sandra, Amd.Kep	PK 2	IKO
29	Ns. Kurnia Setyawansyah, S.Kep	PK 2	IKO
30	Ns. Afni Pandiyagalehi, S.Kep	PK 3	IKO
31	Anita Sari, Amd.Keb	PK 3	IKO
32	Ns. Yurike Devita, S.Kep	PK 2	IKO
33	Eko Pambudi, Amd.Kep	PK 2	IKO
34	Ns. Ferry Kuswantoro, S.Kep.	PK 2	IKO
35	Ns. Agus Hendra, S. Kep	PK 2	IKO
36	M. Andy Gusti, Amd.Kep	PK 2	IKO
37	Puput Sekar Nariratih, Amd.Keb, SE	PK 2	IRJA
38	Ns. Betdi Prasetio, S. Kep	PK 2	IRJA
39	Ns. Isa Ariyanti, S. Kep	PK 2	IRJA
40	Ns. Winda Lestari, S. Kep	PK 2	IRJA
41	Ns. Anggun Tria Istiqomah, S. Kep	PK 2	IRJA
42	Ns. Cyntia Sapta Anggraeni, S. Kep	PK 2	IRJA
43	Ns. Arobiatul Adawiyah, S. Kep	PK 2	IRJA
44	Ns. Rara Ayu Dewanti, S. Kep	PK 2	IRJA
45	Ns. Tika Aryani Damayanti, S. Kep	PK 1	IRJA

46	Yuni Novita, AMd. Kep	PK 2	IRJA
47	Sistha Ghea Aprilia, AMd. Kep	PK 2	IRJA
48	Adelia May Adetry, AMd. Kep	PK 2	IRJA
49	Khairun Nisa, AMd.Kep	PK 1	IRJA
50	Dyah Kusuma W, AMd. Kep	PK 2	IRJA
51	Ria Christiasari, Amd.Kep	PK 2	IRJA
52	Ardian Wika Prasetyo Waseso, AMd. Kep	PK 1	IRJA
53	Raysa Rosadila, Amd. Kep	PK 2	IRJA
54	Wibowo Krisdianto, Amd. Kep	PK 2	IRJA
55	Maulidya Sari, Amd. Kep	PK 2	IRJA
56	Hana Hamimah, Amd. Keb	PK 2	IRJA
57	Leny Puji Rahayu, Amd. Keb	PK 2	IRJA
58	Aneta Putri, Amd. Keb	PK 2	IRJA
59	Tuti Dwi Jayati, Amd. Keb	PK 2	IRJA
60	Ajeng Ika Octavianna, SST	PK 2	IRJA
61	Reyna Oktavia Kristianti, Amd.Kep	PK 1	IRJA
62	Andraina Wulandari, S.Kep.Ns	PK 2	IRJA
63	Indah Maulhayati, S. Kep. Ns	PK 2	2C
64	Murwani Suryaning S, Amd.Kep	PK 2	2C
65	Elok Lonchat Okyani, S.Kep.,Ns	PK 1	2C
66	Neni Novitasari, AMd. Kep	PK 1	2C
67	Elvin Elsa S.Ter.Kep	PK 1	2C
68	Yolanda Sylviana, S.Kep.,Ns	PK 1	2C
69	Wahlah, S.Kep.,Ns	PK 1	2C
70	Nurfi , S.Kep.,Ns	PRA PK	2C
71	Khusnul Khotimah,Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
72	Resa Novitasari, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
73	Dyah Palupi,Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
74	Siti Chomariah, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
75	Syaraswati Silanda, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
76	Oktavia Ameliasari, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
77	Rizky Ningrum Nadia, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
78	Arif Setya Pamuji, Amd.Kep	PK 2	3C ANAK
79	Nuraini Radika Rifqi, S.Kep, Ns	PK 1	3C ANAK
80	Prima Dio P,S.Kep.Ns	PK 1	3C ANAK
81	Arifin Nur Permadi, S.Kep,Ns	PRA PK	3C ANAK
82	Yusrotul Widat, Amd.Kep	PK 1	3C ANAK
83	Saudah, S.Kep,Ns	PRA PK	3C ANAK
84	Mike Maulina H,S.Kep,Ns	PRA PK	3C ANAK
85	Alfiah Indrawati, Amd. Kep	PRA PK	3C ANAK
86	Ns. Wiwit Indah Yanti S. Kep	PK 3	3A & 4A
87	Ns. Roida Saputri, S. Kep	PK 2	3A & 4A
88	Yulinar Indreswari Ratnaningtyas, AMd. Kep	PK 2	3A & 4A
89	Iqbal, AMd. Kep	PK 2	3A & 4A
90	Wahyuni, AMd. Kep	PK 2	3A & 4A
91	Eliadi Putro, AMd.Kep	PK 1	3A & 4A
92	Ns. Ulfa Agustina, S. Kep	PK 2	3A & 4A

93	Ns. Nura'ini, S. Kep	PK 1	3A & 4A
94	Ifvico Regita Moniq, AMd. Kep	PK 2	3A & 4A
95	Ns. Rahil Zilfah, S. Kep	PK 1	3A & 4A
96	Ns. Evita Munjayati, S. Kep	PK 2	3A & 4A
97	Ns. Arlia Safitri, S.Kep	PRA PK	3A & 4A
98	Ns. Anis Nurlaili, S. Kep	PK 1	3A & 4A
99	Ns. Firda Ayu Maghfiro, S. Tr, Kep	PK 1	3A & 4A
100	Fitri Oktavia, AMd. Kep	PK 1	3A & 4A
101	Muhammad Sahri, AMd. Kep	PK 2	3A & 4A
102	Ns. Anik Wahyu Y, S. Kep	PRA PK	3A & 4A
103	Kristina Ratih Dwi AMd. Kep	PRA PK	3A & 4A
104	Siti Zaimah, AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
105	Triasih,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
106	Uswatul Chorida,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
107	Elok Oktaviana,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
108	Aulia Paramita,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
109	Novita Rosunah,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
110	Elisa Lifatinnura,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
111	Faiza Muawanah Z,S.ST	PK 2	MATERNITAS
112	Putri Adi Ramadhania,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
113	Fifi Wahyuningsih,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
114	Ria Widyawati,AMD. KEB	PK 2	MATERNITAS
115	Ns. Dhora Putri Meryda S. Kep	PK 2	NEO
116	Ns. Dyah Dwi Wahyuningsih, S. Kep	PK 2	NEO
117	Ns. Eka Indri Puspita Sari, S.Kep, AMd. Kep	PK 2	NEO
118	Diah Lusiana Eko Tohari, Amd. Kep	PK 2	NEO
119	Sefira Herisky, AMd. Kep	PK 2	NEO
120	Ns. Rismaya Felantriardianti.Kep	PK 1	NEO
121	Agustia Feronika Sari, Amd.Kep	PK 2	NEO
122	Rista Alfia Sari, Amd.Kep	PK 1	NEO
123	Safitri Retno Kurniawati, AMd. Kep	PK 2	NEO
124	Amilatul Kholifah, AMd. Kep	PK 2	5C
125	Laras Wieny Nuriska AMd.Kep	PK 2	5C
126	Tri Ani Darma Wanti AMd.Kep	PK 2	5C
127	Ani Dwi Karimah, S.Kep,Ns	PK 2	5C
128	Nike Kristanti AMd.Kep	PK 2	5C
129	Faidatul Chasanah AMd.Kep	PK 1	5C
130	Ni Made, S. Tr. Kep	PRA PK	5C
131	Tutik Alawiyah, AMd. Kep	PK 1	5C
132	Sintya Rahma Esa S.Kep.Ns	PRA PK	5C
133	M.Ikhwanudin, S.Kep.Ns	PK 1	5C
134	Ns. Cindytya Andrawina, S. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8
135	Billy Mavino Perkasa, AMd. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8
136	Nurul Cintya Laila Ramadhani, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
137	Ahmad Fadhil Kurniawan, AMd. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8

138	Octa Fitri Mu'azizah, S. Tr. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8
139	Ayu Regita Cahyani, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
140	Purwinda Respati Putri, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
141	Saghita Puspitasari, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
142	Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
143	Lailatul Badriyah, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
144	Fella Pancarani, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
145	Ns. Linanda Devi Setya Pramita, S. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8
146	Rendra Tohedy, AMd. Kep	PK 2	IRNA 6,7,8
147	Lovely Aulia Edy, AMd. Kep	PK 1	IRNA 6,7,8
148	Ns. Sabbih Azma Ridlo, S. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
149	Meilinda Dwi Trisutanti, AMd. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
150	Ns. Putra Kukuh Catur Ari, S. Tr. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
151	Ns. Nazhilatur Rizkia, S. Tr. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
152	Ns. Mochamad Fahad, S. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
153	Ns. Nofera Leonora Anggrekmia Eka Saputri, S. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
154	Fathimatuzzahroh, AMd. Kep	PRA PK	IRNA 6,7,8
155	Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep	PK 3	ICU
156	Ns. Rita Purnama Sari, S. Kep	PK 2	ICU
157	Ns. Tatik Widayati, Kep	PK 2	ICU
158	Ns. Artika Wulandari, S. Kep	PK 2	ICU
159	Agus Widodo, Amd. Kep	PK 2	ICU
160	Ikha Farida Octaviana, AMd. Keb	PK 2	ICU
161	Septian Teguh Imanda, AMd. Kep	PK 1	ICU
162	Ns. Ratih Aji Suryamanjari, S. Kep	PK 2	ICU
163	Michael Ardhi Brahmananto, Amd. Kep	PRA PK	ICU
164	Ns. Diyah Purwanti, S. Kep	PK 1	ICU
165	Ns. Bagus Ardiansyah Putra, S. Kep	PK 1	ICU
166	Ners. Devi Erlina Mandasari, STr. Kep	PRA PK	ICU
167	Indha maghfirotin, Amd. Kep	PRA PK	ICU
168	Ferianto Hendri Cahyono., A.Md. Kep	PK 1	ICU
169	Ns. Achmad Rudy Harianto S. Kep	PK 2	ICU
170	Ns. Fariz Tiarawan F.C, S. Kep	PK 2	ICU
171	Rahma Yunita, Amd. Kep	PRA PK	ICU
172	Yayuk Rinika Maria Sari, A.Md. Kep	PRA PK	3A & 4A